BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC

Quy trình Phẫu thuật Gây mê hồi sức

Bản hoàn thiện để trình thẩm định năm 2026

Ngày rà soát 14/10/2026. Tài liệu gồm 19 quy trình từ bản gốc anh cung cấp, hoàn thiện để khoa và Hội đồng chuyên môn xem xét trước ban hành. Bản gốc được giữ nguyên.

Các quy trình kỹ thuật trình bày theo đề cương QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023. Hai quy trình chăm sóc sử dụng nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Nội dung vô cảm, liều thuốc và xử trí cấp cứu cần được khoa GMHS thẩm định bằng hướng dẫn chuyên ngành và danh mục thực tế của bệnh viện.

Nội dung	Xác nhận
Người biên soạn	……
Người thẩm định	……
Người phê duyệt	……
Số quyết định ngày hiệu lực	……

Nguyên tắc áp dụng và các điểm đã cập nhật

QĐ3023 là căn cứ đề cương và thể thức, không phải nguồn quy định mọi thao tác lâm sàng. Các hướng dẫn quốc tế dưới đây là tài liệu đối chiếu chuyên môn, không được gọi là quy định bắt buộc của Bộ Y tế.

Giữ 19 tên quy trình; phân biệt chuẩn bị người bệnh trước mổ của điều dưỡng với khám và quyết định vô cảm của bác sĩ. Tên gọi phòng vô trùng được giải thích theo chức năng thực tế, không coi mọi buồng bệnh là môi trường vô khuẩn.

Bỏ chỉ dẫn dùng quạt halogen dân dụng theo công suất và khoảng cách cố định; thay bằng thiết bị làm ấm y tế phù hợp hướng dẫn nhà sản xuất. Bỏ dao cạo lông; chỉ cắt lông khi cần bằng máy chuyên dụng.

Bổ sung kiểm tra thuốc tê theo tổng liều mg, phân công đúng phạm vi, nhũ tương lipid 20%, capnography, kiểm tra bóng chèn theo áp lực và tiêu chí hồi phục giãn cơ khi rút nội khí quản. Bỏ lịch ngừng thuốc chống đông và thuốc đái tháo đường áp dụng chung cho mọi người bệnh.

Thay các chỉ dẫn tiêm lidocaine hoặc papaverine thường quy khi thoát mạch hoặc tiêm nhầm động mạch bằng ngừng thuốc và xử trí theo loại thuốc, hội chẩn. Bổ sung an toàn bơm giảm đau và xử lý dụng cụ máy thở theo phân loại, tính tái sử dụng và hướng dẫn sản phẩm.

Trước ban hành, khoa xác nhận model thiết bị làm ấm và máy thở; giới hạn liều từng thuốc tê và thuốc mê; bộ LAST; quy trình đường thở khó; tần suất theo dõi hồi tỉnh; tiêu chí chuyển khoa. Các mã tài liệu và biểu mẫu trong bản này là đề xuất, chưa phải quyết định của bệnh viện.

Bản gốc trích QĐ782/QĐ-BYT ngày 04/3/2016. Trang Cục Quản lý Khám chữa bệnh có mục tài liệu này nhưng ghi QĐ-KCB và đường tải toàn văn hiện không hoạt động. Bản này không xác nhận đã đối chiếu đủ 500 quy trình hoặc tình trạng hiệu lực toàn bộ; cần đối chiếu bản quyết định ký và phụ lục của khoa khi thẩm định. Không dùng các tài liệu ghi tên chung, thiếu ấn bản làm căn cứ duy nhất.

Danh mục quy trình

01 Làm ấm người bệnh bằng thiết bị y tế
02 Chăm sóc người bệnh trong buồng có yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt
03 Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật
04 Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật
05 Chuẩn bị vệ sinh người bệnh trước phẫu thuật
06 Kiểm tra an toàn phẫu thuật và thủ thuật
07 Làm sạch vùng mổ trước phẫu thuật
08 Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách và hỗ trợ vô cảm khi cần
09 Gây tê thần kinh gốc ngón chân theo mốc giải phẫu
10 Gây tê thần kinh gốc ngón tay theo mốc giải phẫu
11 Gây tê các thần kinh ở cổ tay
12 Thăm khám trước gây mê và phân loại tình trạng thể chất ASA
13 Theo dõi carbon dioxide cuối thì thở ra $EtCO_2$
14 Theo dõi và sử dụng thuốc giảm đau liên tục
15 Thay băng vết mổ
16 Gây mê tĩnh mạch với hỗ trợ thông khí qua mặt nạ
17 Đặt nội khí quản
18 Rút nội khí quản
19 Làm sạch và khử khuẩn máy thở cùng phụ kiện

01 Làm ấm người bệnh bằng thiết bị y tế

Mã đề xuất QT PTGMHS 01 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Làm ấm chủ động để phòng và xử trí hạ thân nhiệt chu phẫu. Quy trình thay nội dung quạt sưởi halogen dân dụng trong bản nguồn; lựa chọn phương tiện dựa trên thiết bị y tế được bệnh viện quản lý.

2 Chỉ định

Người bệnh có nguy cơ hạ thân nhiệt hoặc thân nhiệt thấp theo nhận định bác sĩ; ở người lớn chu phẫu, nhiệt độ dưới 36°C cần được đánh giá để làm ấm phù hợp.

3 Chống chỉ định

Không dùng thiết bị hỏng, không xác định được hướng dẫn sử dụng, hoặc có chống chỉ định của sản phẩm. Không tiếp tục làm ấm khi tăng thân nhiệt hoặc bác sĩ chỉ định tránh làm tăng nhiệt.

4 Thận trọng

Người bệnh giảm cảm giác, an thần, trẻ em, da tổn thương, tưới máu kém; nguy cơ bỏng và cháy trong môi trường giàu oxy. Nhiễm khuẩn đơn thuần không phải chống chỉ định mọi phương pháp làm ấm.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng được huấn luyện thiết bị, phối hợp bác sĩ GMHS.

5.2 Thuốc

Không có thuốc đặc hiệu bắt buộc; dịch truyền được làm ấm chỉ bằng hệ thống tương thích theo chỉ định.

5.3 Vật tư

Chăn hoặc vật tư đúng loại của thiết bị, khăn và vật tư bảo vệ da theo hướng dẫn sản phẩm.

5.4 Trang thiết bị

Thiết bị làm ấm y tế, nhiệt kế phù hợp và monitor khi cần. Không thay bằng quạt halogen dân dụng.

5.5 Người bệnh

Đo thân nhiệt, đánh giá da, giải thích, giữ kín đáo và tránh mất nhiệt.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Trong chu phẫu theo đáp ứng; ghi thời điểm bắt đầu kết thúc.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng mổ, hồi tỉnh hoặc buồng bệnh được bố trí an toàn.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra chỉ định, nhiệt độ, da và hướng dẫn đúng model thiết bị; xác nhận nguồn điện, cảnh báo và vật tư tương thích.

Bước 2. Đặt người bệnh và thiết bị theo hướng dẫn; bảo vệ vùng tổn thương và kiểm soát nguy cơ nguồn nhiệt gần oxy, vật liệu dễ cháy.

Bước 3. Khởi động và chọn mức nhiệt theo hướng dẫn sản phẩm, tình trạng người bệnh. Thiết bị khí ấm phải dùng chăn tương thích, không thổi đầu ống trực tiếp lên da.

Bước 4. Theo dõi thân nhiệt và da; giảm hoặc dừng khi nóng rát, đỏ da, tăng thân nhiệt hay cảnh báo. Điều chỉnh theo bác sĩ, không dựa vào cảm giác lạnh đơn thuần.

Bước 5. Kết thúc theo mục tiêu, tắt thiết bị đúng trình tự, vệ sinh và ghi nhiệt độ trước trong sau cùng thời gian, chế độ sử dụng.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Bỏng hoặc bất thường da: ngừng nguồn nhiệt, đánh giá và báo bác sĩ; xử trí tổn thương theo phác đồ.

Hạ thân nhiệt kéo dài: đánh giá nguyên nhân, tuần hoàn và mất máu; bác sĩ quyết định bổ sung phương pháp. Thiết bị có sự cố phải cách ly, báo bộ phận thiết bị.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE CG65 Hypothermia prevention and management in adults having surgery. Nguồn đối chiếu

2. Hướng dẫn nhà sản xuất của thiết bị thực tế phải được khoa bổ sung vào hồ sơ thẩm định.

02 Chăm sóc người bệnh trong buồng có yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt

Mã đề xuất QTCS PTGMHS 02 Phiên bản trình thẩm định 1.0

Áp dụng theo chức năng buồng và chỉ định cách ly bảo vệ hoặc cách ly nguồn lây. Cụm từ phòng vô trùng của nguồn không đồng nghĩa mọi chăm sóc cần áo và găng vô khuẩn hoặc mọi buồng đều có áp lực dương.

1 Nhận định

Nhận bàn giao, đánh giá ABCDE, dấu hiệu sinh tồn, ý thức, tình trạng da, dinh dưỡng, vết mổ, catheter, nguy cơ nhiễm khuẩn và nhu cầu hỗ trợ.

Xác định lý do bố trí buồng, đường lây hoặc suy giảm miễn dịch. Kiểm tra chức năng thông khí và yêu cầu PPE đã được KSNK xác nhận; buồng cách ly lây qua không khí và buồng bảo vệ có yêu cầu khác nhau.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan suy giảm miễn dịch, vết thương hoặc dụng cụ xâm lấn.

Thiếu khả năng tự chăm sóc, nguy cơ tổn thương da, lo âu hoặc vấn đề khác có bằng chứng nhận định. Không gán tất cả chẩn đoán cho mọi người bệnh.

3 Lập kế hoạch

Đặt mục tiêu người bệnh an toàn, dụng cụ thông suốt, chăm sóc đúng kỹ thuật và phát hiện sớm nhiễm khuẩn.

Điều dưỡng lập lịch chăm sóc và theo dõi theo mức độ nặng; bác sĩ quyết định điều trị, KSNK xác định môi trường và cách ly. Chuẩn bị vật tư riêng, khu sạch bẩn và phương tiện cấp cứu.

4 Thực hiện

Vệ sinh tay đúng thời điểm. Mang PPE theo nguy cơ đường lây và thao tác; găng vô khuẩn dành cho thủ thuật cần vô khuẩn, không mặc định cho mọi vệ sinh cá nhân.

Ra vào theo quy định buồng; đóng cửa, hạn chế người và vật không cần thiết, không thay đổi áp lực phòng tùy ý.

Theo dõi sinh hiệu và thực hiện vệ sinh, dinh dưỡng, vận động, bảo vệ da; chăm sóc đường truyền và vết thương bằng kỹ thuật không chạm các phần vô khuẩn thiết yếu.

Dùng thuốc theo y lệnh và kiểm tra an toàn; lấy mẫu đúng định danh, bảo quản và vận chuyển. Không dùng hệ thống khí dung hoặc khử khuẩn không khí thường quy nếu chưa có chỉ định và quy trình được duyệt.

Sốt, rét run, khó thở, tụt huyết áp hoặc thay đổi ý thức: gọi bác sĩ, đánh giá ABCDE, cấp cứu theo tình trạng; ghi thời điểm và đáp ứng.

Tháo PPE tại vị trí quy định, vệ sinh tay giữa các bước cần thiết; chuyển dụng cụ bẩn bằng hộp kín, phân loại chất thải, vệ sinh bề mặt bằng hóa chất tương thích. Ghi hồ sơ và bàn giao nguy cơ, y lệnh, thiết bị.

5 Đánh giá

Đánh giá lại dấu hiệu nhiễm khuẩn, da, catheter, sinh hiệu và khả năng tự chăm sóc mỗi ca và khi có bất thường.

So sánh mục tiêu với kết quả, cập nhật kế hoạch; báo KSNK khi hệ thống buồng không đáp ứng hoặc có vi phạm gây nguy cơ.

Tài liệu đối chiếu

1. CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Summary Recommendations. Nguồn đối chiếu

2. Hướng dẫn cách ly và kế hoạch chăm sóc được bệnh viện phê duyệt theo đúng chức năng buồng.

03 Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật

Mã đề xuất QTCS PTGMHS 03 Phiên bản trình thẩm định 1.0

Điều dưỡng tiếp nhận, theo dõi và chăm sóc từ hồi tỉnh đến khoa điều trị theo mức độ nặng, loại mổ và y lệnh; bác sĩ quyết định điều trị và tiêu chí chuyển người bệnh.

1 Nhận định

Nhận ISBAR: danh tính, chẩn đoán, loại và vị trí mổ, vô cảm, đường thở, thuốc cuối cùng, dịch máu, diễn biến và biến cố.

Đánh giá ABCDE, ý thức, đau bằng thang phù hợp, buồn nôn, thân nhiệt, vết mổ, dẫn lưu, đường truyền, lượng nước tiểu và cân bằng dịch.

Xác định nguy cơ chảy máu, suy hô hấp hoặc tồn dư giãn cơ, an thần quá mức, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn, té ngã, tổn thương do tỳ đè và huyết khối.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Đau cấp liên quan tổn thương sau mổ khi có dấu hiệu đau.

Thông khí hoặc trao đổi khí không hiệu quả nếu có bằng chứng; nguy cơ hít sặc, chảy máu, nhiễm khuẩn, hạ thân nhiệt hoặc giảm khả năng vận động theo nhận định.

3 Lập kế hoạch

Mục tiêu hô hấp và tuần hoàn ổn định, đau đạt mục tiêu đã thỏa thuận, dẫn lưu thông, không xuất hiện tổn thương mới.

Lập tần suất theo dõi theo tình trạng và y lệnh. Tại hồi tỉnh duy trì giám sát trực tiếp, theo dõi hô hấp, SpO_2 và huyết động phù hợp; tăng theo dõi sau dùng opioid hoặc khi bất thường.

4 Thực hiện

Tiếp nhận có đủ thiết bị và nhân lực; kiểm tra ngay đường thở, thở, tuần hoàn, định danh, tư thế và các ống.

Bảo đảm đường thở, oxy theo mục tiêu, theo dõi thông khí; khi người bệnh giảm tỉnh hoặc thở yếu, gọi hỗ trợ và xử trí ABC, không chỉ tăng oxy.

Đánh giá đau trước và sau dùng thuốc; thực hiện y lệnh và theo dõi an thần, thở chậm, nôn, bí tiểu. Hỗ trợ tư thế, thư giãn và tập thở.

Quan sát băng, vết mổ và số lượng màu dịch dẫn lưu; giữ hệ thống đúng vị trí, không tự rút hoặc kẹp. Dịch máu tăng, tụt huyết áp hoặc bụng chướng đau tăng: báo bác sĩ ngay.

Làm ấm phù hợp; dinh dưỡng và nước uống theo mức hồi tỉnh, nguy cơ sặc và loại mổ; không áp dụng một lịch ăn uống cho mọi phẫu thuật.

Vận động và dự phòng huyết khối theo chỉ định; bảo vệ da, phòng té ngã, theo dõi bài tiết và hướng dẫn người bệnh.

Chuyển khoa khi bác sĩ đánh giá đạt tiêu chí hồi tỉnh của bệnh viện; bàn giao trực tiếp ISBAR, ghi sinh hiệu cuối, thuốc, dịch, ống, nguy cơ và kế hoạch theo dõi.

5 Đánh giá

Ghi kết quả so với mục tiêu mỗi ca; đánh giá lại đau sau can thiệp, hô hấp sau thuốc và bất kỳ thay đổi sinh hiệu nào.

Suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, chảy máu hoặc sốc: kích hoạt cấp cứu ngay và thực hiện phác đồ. Cập nhật kế hoạch chăm sóc và bàn giao mọi bất thường chưa giải quyết.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

2. NICE CG65 Hypothermia prevention and management in adults having surgery. Nguồn đối chiếu

04 Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật

Mã đề xuất QT PTGMHS 04 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Điều dưỡng hoàn tất chuẩn bị và bàn giao; thăm khám, phân loại ASA và kế hoạch vô cảm do bác sĩ thực hiện tại quy trình 12.

2 Chỉ định

Người bệnh có kế hoạch phẫu thuật hoặc phẫu thuật cấp cứu.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung cho chuẩn bị; trong cấp cứu ưu tiên hồi sức và không trì hoãn vì việc chuẩn bị không thiết yếu.

4 Thận trọng

Nguy cơ đường thở khó, hít sặc, chảy máu, suy dinh dưỡng, bệnh nền mất kiểm soát và thuốc đang dùng.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng cùng bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ GMHS và nhân lực vận chuyển.

5.2 Thuốc

Theo y lệnh cụ thể; đối chiếu thuốc thường dùng và liều cuối, không tự ngừng hoặc tăng giảm thuốc.

5.3 Vật tư

Vòng định danh, bảng kiểm, trang phục sạch và vật tư cho đường truyền theo chỉ định.

5.4 Trang thiết bị

Thiết bị đo sinh hiệu, giường vận chuyển, oxy và phương tiện cấp cứu phù hợp.

5.5 Người bệnh

Giải thích, bảo đảm riêng tư, hỏi dị ứng, ăn uống cuối cùng, tiền sử vô cảm và thuốc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo thời gian chuẩn bị ca mổ, có thể rút gọn theo ưu tiên cấp cứu.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khoa điều trị, tiền phẫu và khu tiếp nhận phòng mổ.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Đối chiếu danh tính, kế hoạch mổ và vị trí; kiểm tra chấp thuận, phiếu khám GMHS và y lệnh.

Bước 2. Nhận định và ghi sinh hiệu, ý thức, nguy cơ đường thở, dinh dưỡng và thuốc; chuyển bác sĩ đánh giá bất thường.

Bước 3. Thực hiện xét nghiệm được chỉ định theo người bệnh và loại mổ; không coi X-quang, điện tim và mọi xét nghiệm là bắt buộc cho mọi trường hợp.

Bước 4. Kiểm tra giờ và loại thức ăn nước uống cuối; làm theo kế hoạch nhịn ăn của bác sĩ GMHS, kể cả thuốc uống. Cấp cứu chưa nhịn đủ cần được bác sĩ đánh giá nguy cơ hít sặc.

Bước 5. Vệ sinh toàn thân và vùng mổ theo quy trình 5 và 7; tháo vật dụng ảnh hưởng an toàn, bảo quản có bàn giao. Kiểm tra đánh dấu vị trí bởi người được phân công.

Bước 6. Thực hiện thuốc, đường truyền, dự phòng và chuẩn bị máu theo y lệnh; kiểm tra đã hoàn thành các điểm nguy cơ.

Bước 7. Ghi bảng kiểm và vận chuyển an toàn, bàn giao ISBAR; xác nhận người nhận và các vấn đề chưa giải quyết.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Bất thường hô hấp, huyết động, đường huyết, dấu nhiễm khuẩn hoặc thiếu hồ sơ quan trọng: báo bác sĩ để quyết định tiếp tục hoặc điều chỉnh kế hoạch.

Nếu sai danh tính hoặc bên mổ, dừng chuyển vào can thiệp để đối chiếu ngay.

Tài liệu đối chiếu

1. AHA ACC Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery, 2024. Nguồn đối chiếu

2. WHO Surgical Safety Checklist và tài liệu triển khai. Nguồn đối chiếu

05 Chuẩn bị vệ sinh người bệnh trước phẫu thuật

Mã đề xuất QT PTGMHS 05 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Vệ sinh toàn thân trước mổ, giữ da sạch và nguyên vẹn; phân biệt với sát khuẩn da tại phòng mổ.

2 Chỉ định

Người bệnh chuẩn bị phẫu thuật hoặc thủ thuật cần làm sạch da.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung; không dùng sản phẩm gây dị ứng hoặc không phù hợp vị trí, độ tuổi.

4 Thận trọng

Tổn thương da, bỏng, hạ thân nhiệt, người bệnh không tự chăm sóc, nguy cơ té ngã. Không dùng dao cạo để loại lông.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng; người hỗ trợ vệ sinh được hướng dẫn, bác sĩ chỉ định khi có tổn thương da.

5.2 Thuốc

Xà phòng hoặc dung dịch làm sạch; sát khuẩn da chỉ khi có chỉ định, chọn sản phẩm theo vị trí và hướng dẫn nhà sản xuất.

5.3 Vật tư

Khăn, găng sạch, quần áo, ga, gạc; máy cắt lông chuyên dụng với đầu cắt phù hợp khi cần.

5.4 Trang thiết bị

Giường hoặc nơi vệ sinh an toàn, đủ sáng và bảo đảm riêng tư.

5.5 Người bệnh

Đánh giá da, khả năng di chuyển, thân nhiệt và giải thích.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Ước tính 20–30 phút tùy mức hỗ trợ; không trì hoãn cấp cứu.

5.8 Địa điểm thực hiện

Buồng bệnh, khu vệ sinh hoặc khu chuẩn bị mổ.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra danh tính, y lệnh, da, dị ứng và nguy cơ ngã; bố trí người hỗ trợ và riêng tư.

Bước 2. Hướng dẫn tắm bằng xà phòng trước mổ; người không tự tắm được hỗ trợ lau tại giường theo tình trạng, giữ ấm và không làm ướt thiết bị.

Bước 3. Làm sạch các nếp da nhẹ nhàng, tráng và lau khô; tránh kéo, làm tuột catheter hoặc dẫn lưu.

Bước 4. Không loại lông thường quy. Nếu lông cản trở can thiệp, cắt bằng máy chuyên dụng sát thời điểm mổ; không cạo bằng dao.

Bước 5. Thay trang phục và ga sạch, đánh giá lại da, ghi việc đã thực hiện và bàn giao.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Chóng mặt hoặc không dung nạp: dừng vệ sinh, bảo đảm an toàn, đánh giá sinh hiệu và báo bác sĩ.

Kích ứng hoặc xây xát: ngừng sản phẩm, đánh giá và ghi hồ sơ; bàn giao tổn thương da cho ê-kíp mổ.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG125 Surgical site infections prevention and treatment. Nguồn đối chiếu

06 Kiểm tra an toàn phẫu thuật và thủ thuật

Mã đề xuất QT PTGMHS 06 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

1.1 Định nghĩa: Quy trình kỹ thuật An toàn trong Phẫu thuật, Thủ thuật là một hệ thống các bước kiểm tra, xác nhận và giao tiếp chuẩn mực, có tổ chức được thực hiện bởi toàn bộ ê-kíp phẫu thuật, thủ thuật trước, trong và ngay sau khi thực hiện kỹ thuật, nhằm đảm bảo đúng người bệnh, đúng vị trí và đúng quy trình.

1.2 Nguyên lý:

Dựa trên nguyên tắc kiểm soát chất lượng và an toàn người bệnh toàn diện.

Sử dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật/thủ thuật để chuẩn hóa việc xác nhận và giao tiếp.

Thực hiện "Dừng lại để kiểm tra" nhằm ngăn ngừa các sai sót nghiêm trọng có thể xảy ra.

2 Chỉ định

Phẫu thuật (từ tiểu phẫu đến đại phẫu).

Thủ thuật có can thiệp xâm lấn, nguy cơ cao hoặc cần phương pháp vô cảm.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung; cấp cứu thực hiện những kiểm tra thiết yếu song song hồi sức.

4 Thận trọng

Sai danh tính, sai vị trí, thiếu dữ kiện và vắng người có trách nhiệm phải được giải quyết ngay; bảng kiểm không được điền hồi tố thay xác nhận trực tiếp.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Toàn ê-kíp; điều dưỡng điều phối bảng kiểm, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ GMHS xác nhận phần chuyên môn.

5.2 Thuốc

Đối chiếu thuốc vô cảm, cấp cứu và kháng sinh dự phòng theo kế hoạch ca mổ.

5.3 Vật tư

Bảng kiểm an toàn, bút hoặc hồ sơ điện tử, nhãn bệnh phẩm.

5.4 Trang thiết bị

Monitor, phương tiện kiểm tra máy gây mê và thông tin hình ảnh cần thiết.

5.5 Người bệnh

Định danh, vị trí đánh dấu khi áp dụng, chấp thuận và nguy cơ cần trao đổi.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Tại ba thời điểm của ca mổ; không áp dụng mốc 6 phút cố định.

5.8 Địa điểm thực hiện

Tiền mê và phòng mổ hoặc phòng thủ thuật.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Trước vô cảm Sign in: xác nhận người bệnh, kỹ thuật, vị trí, chấp thuận và đánh dấu; kiểm tra máy, thuốc, SpO_2 hoạt động, dị ứng, nguy cơ đường thở hít sặc và mất máu, kế hoạch đường truyền máu.

Bước 2. Trước rạch da Time out: toàn ê-kíp dừng để giới thiệu và xác nhận người bệnh, vị trí, kỹ thuật; trao đổi bước khó, thời gian, mất máu, vấn đề GMHS, vô khuẩn, thiết bị và hình ảnh.

Bước 3. Xác nhận kháng sinh dự phòng khi có chỉ định và thời điểm dùng phù hợp thuốc. Bảng kiểm WHO hỏi đã dùng trong 60 phút; thuốc truyền kéo dài cần kế hoạch thời điểm riêng, không áp một mốc cho mọi thuốc.

Bước 4. Kiểm đếm dụng cụ, kim và gạc theo các thời điểm của quy định bệnh viện, gồm trước đóng khoang hoặc đóng vết mổ; nếu lệch phải báo phẫu thuật viên và kiểm tra theo quy trình, không chỉ ghi nhận.

Bước 5. Trước người bệnh rời phòng Sign out: xác nhận tên kỹ thuật đã làm, kiểm đếm, nhãn bệnh phẩm bằng đọc xác nhận, vấn đề thiết bị và kế hoạch hồi phục; hoàn thiện chữ ký người chịu trách nhiệm.

Bước 6. Bàn giao ISBAR đến hồi tỉnh hoặc đơn vị nhận, xác nhận các điểm nguy cơ và y lệnh.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Sai định danh hoặc vị trí: dừng can thiệp để đối chiếu. Cấp cứu đe dọa tính mạng do bác sĩ quyết định ưu tiên và ghi lý do.

Lệch kiểm đếm hoặc sai nhãn bệnh phẩm phải khắc phục trước hoàn tất bàn giao; báo cáo sự cố theo quy định bệnh viện.

Chỉ số giám sát: tỷ lệ đủ ba thời điểm, tỷ lệ kiểm đếm và hồ sơ hoàn chỉnh; mục tiêu do bệnh viện phê duyệt, không tuyên bố không thể có sự cố.

Tài liệu đối chiếu

1. WHO Surgical Safety Checklist và tài liệu triển khai. Nguồn đối chiếu

07 Làm sạch vùng mổ trước phẫu thuật

Mã đề xuất QT PTGMHS 07 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Làm sạch vùng da dự kiến mổ trước sát khuẩn và trải khăn. Sát khuẩn phẫu trường là bước riêng theo sản phẩm, không coi rửa sạch tương đương sát khuẩn.

2 Chỉ định

Người bệnh chuẩn bị phẫu thuật hoặc thủ thuật cần làm sạch da.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung; không dùng sản phẩm gây dị ứng hoặc không phù hợp vị trí, độ tuổi.

4 Thận trọng

Tổn thương da, bỏng, hạ thân nhiệt, người bệnh không tự chăm sóc, nguy cơ té ngã. Không dùng dao cạo để loại lông.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng; người hỗ trợ vệ sinh được hướng dẫn, bác sĩ chỉ định khi có tổn thương da.

5.2 Thuốc

Xà phòng hoặc dung dịch làm sạch; sát khuẩn da chỉ khi có chỉ định, chọn sản phẩm theo vị trí và hướng dẫn nhà sản xuất.

5.3 Vật tư

Khăn, găng sạch, quần áo, ga, gạc; máy cắt lông chuyên dụng với đầu cắt phù hợp khi cần.

5.4 Trang thiết bị

Giường hoặc nơi vệ sinh an toàn, đủ sáng và bảo đảm riêng tư.

5.5 Người bệnh

Đánh giá da, khả năng di chuyển, thân nhiệt và giải thích.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Ước tính 10–15 phút tùy vùng mổ.

5.8 Địa điểm thực hiện

Buồng bệnh, khu vệ sinh hoặc khu chuẩn bị mổ.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Định danh, kiểm tra bên mổ và đánh dấu, y lệnh, dị ứng, da và tổn thương; bố trí tư thế và riêng tư.

Bước 2. Làm sạch vùng mổ bằng xà phòng hoặc sản phẩm phù hợp; loại chất bẩn nhẹ nhàng và không làm trầy da.

Bước 3. Nếu cần loại lông, dùng máy cắt chuyên dụng, không dùng dao cạo; giữ vị trí đánh dấu vẫn nhận biết được.

Bước 4. Lau khô, đánh giá và báo bất thường. Sát khuẩn phẫu trường dùng sản phẩm phù hợp theo hướng dẫn, tránh tiếp xúc mắt niêm mạc khi không được phép.

Bước 5. Với sản phẩm chứa cồn, tránh đọng dưới người bệnh và chờ khô hoàn toàn trước trải khăn hoặc dùng nguồn nhiệt, dao điện.

Bước 6. Ghi sản phẩm, thời điểm và đáp ứng; bàn giao người bệnh.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Chóng mặt hoặc không dung nạp: dừng vệ sinh, bảo đảm an toàn, đánh giá sinh hiệu và báo bác sĩ.

Kích ứng hoặc xây xát: ngừng sản phẩm, đánh giá và ghi hồ sơ; bàn giao tổn thương da cho ê-kíp mổ.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG125 Surgical site infections prevention and treatment. Nguồn đối chiếu

08 Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách và hỗ trợ vô cảm khi cần

Mã đề xuất QT PTGMHS 08 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Gây tê đám rối thần kinh cánh tay nách là kỹ thuật gây tê vùng được thực hiện bằng cách đưa thuốc tê hoặc hỗn hợp thuốc tê vào bao đám rối thần kinh cánh tay. Dựa vào đặc điểm về giải phẫu, đường đi và liên quan để gây tê đám rối thần kinh cánh tay kết hợp với gây mê úp mặt nạ hỗ trợ.

2 Chỉ định

Vô cảm để phẫu thuật ở chi trên.

Vô cảm để nắn sai khớp chi trên.

Giảm đau sau mổ chi trên.

3 Chống chỉ định

Người bệnh từ chối.

Dị ứng thuốc tê, thuốc mê.

Viêm nhiễm vùng chọc kim gây tê.

Rối loạn đông máu nặng.

Không đủ phương tiện hồi sức.

Không thành thạo kĩ thuật.

4 Thận trọng

Đánh giá đông máu và thuốc chống đông, bệnh thần kinh sẵn có, bệnh gan tim, tuổi và cân nặng. Ghi tình trạng cảm giác, vận động, tưới máu trước gây tê. Dừng tiêm khi đau buốt, dị cảm kéo dài, sức cản cao hoặc nghi tiêm vào mạch; hút không có máu không loại trừ hoàn toàn nguy cơ vào mạch. Gây mê hỗ trợ phải có kế hoạch độc lập; vị trí mổ và yêu cầu garô có thể cần phong bế bổ sung.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực gây tê vùng, được phân công trong phạm vi hành nghề; điều dưỡng hỗ trợ chuẩn bị, theo dõi và thực hiện y lệnh. Chứng nhận đào tạo riêng không tự mở rộng phạm vi hành nghề.

5.2 Thuốc

Thuốc tê do bác sĩ chọn và ghi rõ tên, nồng độ, tổng thể tích, tổng liều mg và giới hạn liều phù hợp cân nặng, bệnh nền, hướng dẫn sản phẩm. Khi phối hợp thuốc tê phải tính độc tính cộng gộp. Chuẩn bị thuốc cấp cứu, benzodiazepine và nhũ tương lipid 20% theo phác đồ LAST được duyệt.

5.3 Vật tư

Kim gây tê phù hợp, bơm tiêm, găng, gạc, khăn vô khuẩn và sát khuẩn tương thích.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động. Siêu âm hoặc máy kích thích thần kinh với thiết bị phù hợp phương pháp được khoa phê duyệt.

5.5 Người bệnh

Khám GMHS, giải thích và chấp thuận; đường truyền, theo dõi, chuẩn bị nguy cơ hít sặc nếu có an thần hoặc gây mê.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo phương pháp và đáp ứng phong bế; không cố định một tổng thể tích cho mọi người bệnh.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu vô cảm đủ điều kiện hồi sức.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra hồ sơ, bên chi, cảm giác vận động và tưới máu ban đầu; xác nhận kế hoạch thuốc, tổng liều và bộ cấp cứu.

Bước 2. Đặt nằm ngửa, tay dạng vừa đủ bộc lộ nách, tránh dạng quá mức hoặc kéo căng; sát khuẩn và thiết lập trường vô khuẩn.

Bước 3. Bác sĩ xác định động mạch nách, các thần kinh mục tiêu và đường kim theo phương pháp đã được duyệt. Nếu dùng siêu âm phải nhìn được đầu kim và hướng lan thuốc; nếu dùng kích thích phải theo thiết bị và kỹ thuật đã được huấn luyện.

Bước 4. Tiêm thuốc tê chậm, chia phần với kiểm tra vị trí và theo dõi liên tục. Không chủ động xuyên động mạch trong quy trình chuẩn này; dừng khi có dấu hiệu nguy hiểm nêu tại mục 4.

Bước 5. Đánh giá cảm giác vận động vùng mổ và hiệu lực trước rạch da; bác sĩ quyết định bổ sung hoặc đổi vô cảm khi chưa đạt.

Bước 6. Nếu cần gây mê hỗ trợ, chuyển sang kế hoạch đã xác nhận, duy trì người theo dõi riêng và phương tiện đường thở, capnography phù hợp; không mặc định mặt nạ là đủ bảo vệ đường thở.

Bước 7. Ghi phương pháp, vị trí, thuốc và tổng mg, thời điểm, đáp ứng và biến cố; bàn giao bảo vệ chi và theo dõi.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi ý thức, nhịp thở, SpO_2, mạch, huyết áp, điện tim và mức độ phong bế; kiểm tra tưới máu chi. Bảo vệ chi mất cảm giác, tránh bỏng và chèn ép.

Nghi ngộ độc thuốc tê toàn thân LAST: ngừng tiêm, gọi hỗ trợ, bảo đảm đường thở và oxy hóa, xử trí co giật và rối loạn tuần hoàn theo phác đồ LAST; lấy bộ nhũ tương lipid 20%. Xem phụ lục cấp cứu LAST. Không giới hạn LAST ở bupivacaine hoặc ropivacaine.

Phản vệ: ngừng tác nhân, kích hoạt cấp cứu và thực hiện phác đồ phản vệ của bệnh viện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline là thuốc thiết yếu. Kháng histamine không thay thế adrenaline.

Tụ máu, thiếu máu chi hoặc tổn thương thần kinh: ngừng can thiệp, đánh giá ngay, báo bác sĩ và hội chẩn khi cần. Phong bế không đủ: bác sĩ đánh giá tổng liều đã dùng và đổi kế hoạch vô cảm; không bơm thêm thuốc thiếu kiểm soát.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

2. ASRA Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity, 2020. Nguồn đối chiếu

09 Gây tê thần kinh gốc ngón chân theo mốc giải phẫu

Mã đề xuất QT PTGMHS 09 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Phong bế các thần kinh cảm giác ngón chân để can thiệp tại ngón.

2 Chỉ định

Khâu vết thương, xử trí móng, lấy dị vật, cắt lọc hoặc nắn chỉnh theo chỉ định.

3 Chống chỉ định

Người bệnh từ chối, dị ứng thuốc được chọn, nhiễm khuẩn tại đường chọc. Thiếu máu ngón cần bác sĩ đánh giá chuyên khoa trước quyết định, không tiêm gây tê tại chỗ tùy tiện.

4 Thận trọng

Đánh giá đông máu và thuốc chống đông, bệnh thần kinh sẵn có, bệnh gan tim, tuổi và cân nặng. Ghi tình trạng cảm giác, vận động, tưới máu trước gây tê. Dừng tiêm khi đau buốt, dị cảm kéo dài, sức cản cao hoặc nghi tiêm vào mạch; hút không có máu không loại trừ hoàn toàn nguy cơ vào mạch. Chọn thuốc không adrenaline trong quy trình này; không coi đây là kết luận mọi dung dịch có adrenaline đều tuyệt đối chống chỉ định trong mọi hoàn cảnh.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực gây tê vùng, được phân công trong phạm vi hành nghề; điều dưỡng hỗ trợ chuẩn bị, theo dõi và thực hiện y lệnh. Chứng nhận đào tạo riêng không tự mở rộng phạm vi hành nghề.

5.2 Thuốc

Thuốc tê do bác sĩ chọn và ghi rõ tên, nồng độ, tổng thể tích, tổng liều mg và giới hạn liều phù hợp cân nặng, bệnh nền, hướng dẫn sản phẩm. Khi phối hợp thuốc tê phải tính độc tính cộng gộp. Chuẩn bị thuốc cấp cứu, benzodiazepine và nhũ tương lipid 20% theo phác đồ LAST được duyệt. Bản nguồn sử dụng lidocaine 1% không adrenaline; chỉ dùng khi bác sĩ xác nhận phù hợp.

5.3 Vật tư

Kim nhỏ, bơm tiêm phù hợp, găng gạc vô khuẩn và dung dịch sát khuẩn.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động.

5.5 Người bệnh

Đánh giá ngón chân, tưới máu, tổn thương, tiền sử thuốc tê; giải thích và chấp thuận.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo thủ thuật và thời gian xuất hiện hiệu lực thuốc.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng thủ thuật hoặc phòng mổ đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác nhận đúng ngón và bên, chỉ định; ghi tưới máu, cảm giác và vận động trước gây tê, kiểm tra thuốc và tổng liều.

Bước 2. Đặt bàn chân trên mặt phẳng ổn định; làm sạch, sát khuẩn vùng tiêm và chờ khô.

Bước 3. Xác định gốc ngón và vị trí thần kinh hai bên theo giải phẫu đã được huấn luyện; tránh mạch và vùng nhiễm khuẩn.

Bước 4. Bác sĩ đưa kim theo đường thích hợp, kiểm tra và tiêm chậm lượng thuốc đủ phong bế trong tổng liều đã tính. Không bơm thành vòng kín dưới áp lực hoặc áp dụng 1 mL mỗi bên cho mọi người bệnh.

Bước 5. Rút kim, ép nhẹ bằng gạc, chờ hiệu lực và kiểm tra cảm giác trước thủ thuật; phong bế không đủ phải đánh giá lại trước bổ sung.

Bước 6. Sau thủ thuật kiểm tra màu, nhiệt, tưới máu và băng; ghi thuốc tổng mg, đáp ứng, hướng dẫn bảo vệ ngón.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi ý thức, nhịp thở, SpO_2, mạch, huyết áp, điện tim và mức độ phong bế; kiểm tra tưới máu chi. Bảo vệ chi mất cảm giác, tránh bỏng và chèn ép.

Nghi ngộ độc thuốc tê toàn thân LAST: ngừng tiêm, gọi hỗ trợ, bảo đảm đường thở và oxy hóa, xử trí co giật và rối loạn tuần hoàn theo phác đồ LAST; lấy bộ nhũ tương lipid 20%. Xem phụ lục cấp cứu LAST. Không giới hạn LAST ở bupivacaine hoặc ropivacaine.

Phản vệ: ngừng tác nhân, kích hoạt cấp cứu và thực hiện phác đồ phản vệ của bệnh viện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline là thuốc thiết yếu. Kháng histamine không thay thế adrenaline.

Tụ máu, thiếu máu chi hoặc tổn thương thần kinh: ngừng can thiệp, đánh giá ngay, báo bác sĩ và hội chẩn khi cần. Phong bế không đủ: bác sĩ đánh giá tổng liều đã dùng và đổi kế hoạch vô cảm; không bơm thêm thuốc thiếu kiểm soát.

Tài liệu đối chiếu

1. ASRA Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity, 2020. Nguồn đối chiếu

10 Gây tê thần kinh gốc ngón tay theo mốc giải phẫu

Mã đề xuất QT PTGMHS 10 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Phong bế các thần kinh cảm giác ngón tay để can thiệp tại ngón.

2 Chỉ định

Khâu vết thương, xử trí móng, lấy dị vật, cắt lọc hoặc nắn chỉnh theo chỉ định.

3 Chống chỉ định

Người bệnh từ chối, dị ứng thuốc được chọn, nhiễm khuẩn tại đường chọc. Thiếu máu ngón cần bác sĩ đánh giá chuyên khoa trước quyết định, không tiêm gây tê tại chỗ tùy tiện.

4 Thận trọng

Đánh giá đông máu và thuốc chống đông, bệnh thần kinh sẵn có, bệnh gan tim, tuổi và cân nặng. Ghi tình trạng cảm giác, vận động, tưới máu trước gây tê. Dừng tiêm khi đau buốt, dị cảm kéo dài, sức cản cao hoặc nghi tiêm vào mạch; hút không có máu không loại trừ hoàn toàn nguy cơ vào mạch. Chọn thuốc không adrenaline trong quy trình này; không coi đây là kết luận mọi dung dịch có adrenaline đều tuyệt đối chống chỉ định trong mọi hoàn cảnh.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực gây tê vùng, được phân công trong phạm vi hành nghề; điều dưỡng hỗ trợ chuẩn bị, theo dõi và thực hiện y lệnh. Chứng nhận đào tạo riêng không tự mở rộng phạm vi hành nghề.

5.2 Thuốc

Thuốc tê do bác sĩ chọn và ghi rõ tên, nồng độ, tổng thể tích, tổng liều mg và giới hạn liều phù hợp cân nặng, bệnh nền, hướng dẫn sản phẩm. Khi phối hợp thuốc tê phải tính độc tính cộng gộp. Chuẩn bị thuốc cấp cứu, benzodiazepine và nhũ tương lipid 20% theo phác đồ LAST được duyệt. Bản nguồn sử dụng lidocaine 1% không adrenaline; chỉ dùng khi bác sĩ xác nhận phù hợp.

5.3 Vật tư

Kim nhỏ, bơm tiêm phù hợp, găng gạc vô khuẩn và dung dịch sát khuẩn.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động.

5.5 Người bệnh

Đánh giá ngón tay, tưới máu, tổn thương, tiền sử thuốc tê; giải thích và chấp thuận.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo thủ thuật và thời gian xuất hiện hiệu lực thuốc.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng thủ thuật hoặc phòng mổ đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác nhận đúng ngón và bên, chỉ định; ghi tưới máu, cảm giác và vận động trước gây tê, kiểm tra thuốc và tổng liều.

Bước 2. Đặt bàn tay trên mặt phẳng ổn định; làm sạch, sát khuẩn vùng tiêm và chờ khô.

Bước 3. Xác định gốc ngón và vị trí thần kinh hai bên theo giải phẫu đã được huấn luyện; tránh mạch và vùng nhiễm khuẩn.

Bước 4. Bác sĩ đưa kim theo đường thích hợp, kiểm tra và tiêm chậm lượng thuốc đủ phong bế trong tổng liều đã tính. Không bơm thành vòng kín dưới áp lực hoặc áp dụng 1 mL mỗi bên cho mọi người bệnh.

Bước 5. Rút kim, ép nhẹ bằng gạc, chờ hiệu lực và kiểm tra cảm giác trước thủ thuật; phong bế không đủ phải đánh giá lại trước bổ sung.

Bước 6. Sau thủ thuật kiểm tra màu, nhiệt, tưới máu và băng; ghi thuốc tổng mg, đáp ứng, hướng dẫn bảo vệ ngón.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi ý thức, nhịp thở, SpO_2, mạch, huyết áp, điện tim và mức độ phong bế; kiểm tra tưới máu chi. Bảo vệ chi mất cảm giác, tránh bỏng và chèn ép.

Nghi ngộ độc thuốc tê toàn thân LAST: ngừng tiêm, gọi hỗ trợ, bảo đảm đường thở và oxy hóa, xử trí co giật và rối loạn tuần hoàn theo phác đồ LAST; lấy bộ nhũ tương lipid 20%. Xem phụ lục cấp cứu LAST. Không giới hạn LAST ở bupivacaine hoặc ropivacaine.

Phản vệ: ngừng tác nhân, kích hoạt cấp cứu và thực hiện phác đồ phản vệ của bệnh viện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline là thuốc thiết yếu. Kháng histamine không thay thế adrenaline.

Tụ máu, thiếu máu chi hoặc tổn thương thần kinh: ngừng can thiệp, đánh giá ngay, báo bác sĩ và hội chẩn khi cần. Phong bế không đủ: bác sĩ đánh giá tổng liều đã dùng và đổi kế hoạch vô cảm; không bơm thêm thuốc thiếu kiểm soát.

Tài liệu đối chiếu

1. ASRA Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity, 2020. Nguồn đối chiếu

11 Gây tê các thần kinh ở cổ tay

Mã đề xuất QT PTGMHS 11 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Phong bế thần kinh giữa, trụ hoặc nhánh cảm giác thần kinh quay theo vùng can thiệp.

2 Chỉ định

Can thiệp bàn tay, ngón tay hoặc bổ sung phong bế theo bác sĩ.

3 Chống chỉ định

Từ chối, dị ứng thuốc, nhiễm khuẩn vị trí chọc; rối loạn đông máu phải đánh giá trước.

4 Thận trọng

Đánh giá đông máu và thuốc chống đông, bệnh thần kinh sẵn có, bệnh gan tim, tuổi và cân nặng. Ghi tình trạng cảm giác, vận động, tưới máu trước gây tê. Dừng tiêm

khi đau buốt, dị cảm kéo dài, sức cản cao hoặc nghi tiêm vào mạch; hút không có máu không loại trừ hoàn toàn nguy cơ vào mạch. Thể tích và độ sâu không áp dụng cố định; bản nguồn có mốc chiều sâu không thống nhất nên không dùng làm chỉ dẫn độc lập.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ có năng lực gây tê vùng, được phân công trong phạm vi hành nghề; điều dưỡng hỗ trợ chuẩn bị, theo dõi và thực hiện y lệnh. Chứng nhận đào tạo riêng không tự mở rộng phạm vi hành nghề.

5.2 Thuốc

Thuốc tê do bác sĩ chọn và ghi rõ tên, nồng độ, tổng thể tích, tổng liều mg và giới hạn liều phù hợp cân nặng, bệnh nền, hướng dẫn sản phẩm. Khi phối hợp thuốc tê phải tính độc tính cộng gộp. Chuẩn bị thuốc cấp cứu, benzodiazepine và nhũ tương lipid 20% theo phác đồ LAST được duyệt.

5.3 Vật tư

Bộ gây tê vô khuẩn, kim phù hợp, sát khuẩn, gạc.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động. Siêu âm khi sử dụng kỹ thuật dưới hướng dẫn siêu âm.

5.5 Người bệnh

Khám vận động cảm giác và tưới máu; xác định vùng chi phối cần phong bế.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo phạm vi phong bế và đáp ứng.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng thủ thuật hoặc phòng mổ đủ điều kiện.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra danh tính, bên chi, chỉ định, thuốc, liều và chức năng thần kinh ban đầu.

Bước 2. Đặt tay, bộc lộ cổ tay và sát khuẩn; bác sĩ xác định gân, động mạch và thần kinh mục tiêu.

Bước 3. Thần kinh trụ: xác định vùng cạnh gân gấp cổ tay trụ và mạch trụ; chọn đường trước hoặc bên theo kỹ thuật được duyệt, tránh mạch và tiêm trong thần kinh.

Bước 4. Thần kinh quay: phong bế nhánh cảm giác nông vùng phía quay theo vùng cần can thiệp; tiêm dưới da có kiểm soát, không chèn ép cổ tay.

Bước 5. Thần kinh giữa: xác định tương quan gân ở mặt gan cổ tay; bác sĩ chọn đường và độ sâu theo giải phẫu hoặc siêu âm, không dựa vào mốc 1,5–2 mm của bản nguồn.

Bước 6. Mỗi vị trí tiêm chậm chia phần, kiểm tra và theo dõi; dừng khi đau buốt hoặc sức cản tăng. Kiểm tra vô cảm trước can thiệp, ghi tổng liều và bàn giao.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi ý thức, nhịp thở, SpO_2, mạch, huyết áp, điện tim và mức độ phong bế; kiểm tra tưới máu chi. Bảo vệ chi mất cảm giác, tránh bỏng và chèn ép.

Nghi ngộ độc thuốc tê toàn thân LAST: ngừng tiêm, gọi hỗ trợ, bảo đảm đường thở và oxy hóa, xử trí co giật và rối loạn tuần hoàn theo phác đồ LAST; lấy bộ nhũ tương lipid 20%. Xem phụ lục cấp cứu LAST. Không giới hạn LAST ở bupivacaine hoặc ropivacaine.

Phản vệ: ngừng tác nhân, kích hoạt cấp cứu và thực hiện phác đồ phản vệ của bệnh viện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; adrenaline là thuốc thiết yếu. Kháng histamine không thay thế adrenaline.

Tụ máu, thiếu máu chi hoặc tổn thương thần kinh: ngừng can thiệp, đánh giá ngay, báo bác sĩ và hội chẩn khi cần. Phong bế không đủ: bác sĩ đánh giá tổng liều đã dùng và đổi kế hoạch vô cảm; không bơm thêm thuốc thiếu kiểm soát.

Tài liệu đối chiếu

1. ASRA Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity, 2020. Nguồn đối chiếu

2. Khoa GMHS cần đối chiếu và phê duyệt sơ đồ mốc giải phẫu cùng hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành trước sử dụng đào tạo thao tác độc lập.

12 Thăm khám trước gây mê và phân loại tình trạng thể chất ASA

Mã đề xuất QT PTGMHS 12 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Chuẩn bị người bệnh trước mổ là việc làm cần thiết đầu tiên cho tất cả các hoạt động gây mê hồi sức tiếp theo. Qua thăm khám, người gây mê hồi sức hiểu rõ được bệnh lý ngoại khoa sắp mổ cũng như các hoạt động phẫu thuật sẽ diễn ra. (chẩn đoán trước mổ và phương pháp phẫu thuật)

Biết được tiền sử bệnh tật của người bệnh và gia đình, thói quen và tình trạng sức khoẻ hiện tại. Trên cơ sở đó, đánh giá được một cách tương đối chính xác bệnh tật và các nguy cơ có thể xảy ra cũng như đề xuất khám chuyên khoa hay xét nghiệm chuyên sâu bổ sung. Sau khi thăm khám người bệnh, người gây mê đưa ra một kế hoạch gây mê và hồi sức tốt nhất cho người bệnh.

2 Chỉ định

Người bệnh dự kiến gây mê, gây tê hoặc an thần có nguy cơ.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định đánh giá; cấp cứu đánh giá nhanh song song hồi sức.

4 Thận trọng

ASA mô tả tình trạng thể chất, không tự quyết định nguy cơ mổ hoặc kết quả; không coi một chẩn đoán đơn lẻ đủ xếp hạng. Mallampati là một yếu tố, không loại trừ đường thở khó.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ GMHS thăm khám và quyết định; điều dưỡng thu thập dữ liệu, chuẩn bị và thực hiện y lệnh.

5.2 Thuốc

Đối chiếu thuốc, chỉ định tiếp tục hoặc ngừng, giờ liều cuối và kế hoạch dùng lại; kế hoạch phải cá thể hóa.

5.3 Vật tư

Phiếu khám GMHS, bảng kiểm, vật tư khám cơ bản.

5.4 Trang thiết bị

Thiết bị đo sinh hiệu và đánh giá đường thở, phương tiện khám cần thiết.

5.5 Người bệnh

Giải thích, hỏi bệnh trực tiếp hoặc người đại diện; rà hồ sơ và thuốc.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Trước vô cảm và đánh giá lại khi tình trạng thay đổi.

5.8 Địa điểm thực hiện

Buồng khám tiền mê, khoa điều trị hoặc khu cấp cứu.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác nhận danh tính, phẫu thuật, bên, tính cấp cứu; khai thác bệnh nền, dị ứng, tiền sử vô cảm đường thở khó, sốt cao ác tính, thói quen và gia đình.

Bước 2. Khám tổng trạng, khả năng hoạt động, tim phổi, ý thức, dinh dưỡng và hệ cơ quan liên quan. Đánh giá đường thở bằng nhiều yếu tố; Cormack Lehane ghi khi soi thanh quản, không thay khám trước mổ.

Bước 3. Rà giờ và loại ăn uống cuối, nguy cơ hít sặc, đường truyền và khả năng cần máu. Chỉ định xét nghiệm phù hợp người bệnh và loại phẫu thuật.

Bước 4. Lập kế hoạch thuốc: thuốc tim mạch, chống đông, kháng tiểu cầu, insulin, thuốc đái tháo đường gồm SGLT2 và GLP1, corticoid và thuốc khác. Ghi cụ thể thuốc nào tiếp tục hoặc ngừng, thời điểm và dùng lại; hội chẩn khi cần. Không ngừng chống đông hoặc kháng tiểu cầu, chuyển heparin theo bảng chung.

Bước 5. Phân loại ASA theo bảng dưới, thêm E khi cấp cứu; bác sĩ ghi đánh giá và yếu tố nguy cơ ngoài ASA.

Bước 6. Điều chỉnh bất thường trong khả năng cho phép; bác sĩ quyết định tiếp tục, hoãn hoặc chuyển mức chăm sóc, giải thích kế hoạch vô cảm và chấp thuận.

Bước 7. Hoàn thiện phiếu khám, y lệnh, kế hoạch đường thở, hồi sức và giảm đau; đánh giá lại trước khởi mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Dấu hiệu mất ổn định phải được bác sĩ đánh giá và tối ưu theo mức cấp cứu. Báo ngay dữ liệu mới hoặc sai khác thuốc, nhịn ăn, dị ứng.

Theo dõi kết quả điều chỉnh, ghi quyết định và bàn giao nguy cơ.

Tài liệu đối chiếu

1. AHA ACC Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery, 2024. Nguồn đối chiếu

2. ASA Physical Status Classification System, nguồn chính thức và công bố DOI 10.1097/ao9.0000000000000002. Nguồn đối chiếu

Phân loại ASA để đối chiếu

Hạng	Diễn giải
I	Người bệnh khỏe mạnh bình thường.
II	Bệnh hệ thống nhẹ.
III	Bệnh hệ thống nặng.
IV	Bệnh hệ thống nặng gây đe dọa thường xuyên tính mạng.
V	Người bệnh hấp hối, không dự kiến sống sót nếu không phẫu thuật; bỏ cách mô tả sống không quá 24 giờ dù mổ hay không.
VI	Người bệnh được xác định chết não, lấy tạng cho mục đích hiến.
E	Ký hiệu bổ sung cho phẫu thuật cấp cứu, không phải hạng ASA riêng.

13 Theo dõi carbon dioxide cuối thì thở ra $EtCO_2$

Mã đề xuất QT PTGMHS 13 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Đo $EtCO_2$ kèm dạng sóng để đánh giá thông khí và hỗ trợ xác nhận đường thở; không thay SpO_2, khí máu hoặc đánh giá lâm sàng.

2 Chỉ định

Đặt ống nội khí quản.

Thở máy.

Gây mê toàn thân.

Hồi sức tim phổi (CPR).

An thần sâu, thủ thuật xâm lấn.

Vận chuyển người bệnh nặng.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung; chọn phụ kiện phù hợp người bệnh và thiết bị.

4 Thận trọng

Rò khí, tắc dây lấy mẫu, nước đọng, tưới máu thấp và khoảng chết có thể làm sai số. $EtCO_2$ 35–45 mmHg chỉ là khoảng tham khảo, không phải mục tiêu cho mọi bệnh lý.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ hoặc điều dưỡng được đào tạo vận hành; bác sĩ quyết định thông khí và xử trí nguyên nhân.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc để đo.

5.3 Vật tư

Adapter hoặc dây lấy mẫu, bẫy nước, canuyn phù hợp; vật tư dùng một lần theo sản phẩm.

5.4 Trang thiết bị

Monitor capnography loại mainstream hoặc sidestream đã kiểm tra, phù hợp đường thở.

5.5 Người bệnh

Kiểm tra đường thở, vị trí ống, theo dõi SpO_2 song song.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Liên tục trong giai đoạn có chỉ định.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng mổ, hồi sức, thủ thuật hoặc vận chuyển có thiết bị phù hợp.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra nguồn điện pin, hiệu chuẩn hoặc tự kiểm tra theo thiết bị, đơn vị và ngưỡng cảnh báo cá thể hóa.

Bước 2. Nối phụ kiện đúng vị trí hướng dẫn nhà sản xuất; hạn chế khoảng chết, lực kéo ống và rò khí. Trẻ nhỏ phải dùng phụ kiện phù hợp.

Bước 3. Xác nhận có dạng sóng và số đo ổn định, đối chiếu nhịp thở, lồng ngực, SpO_2 và mạch; theo dõi xu hướng liên tục.

Bước 4. Mất hoặc giảm sóng đột ngột: đánh giá người bệnh và đường thở trước, kiểm tra mất kết nối, tụt ống, tắc, ngừng thở và tuần hoàn; gọi hỗ trợ, thông khí khi cần. Không chỉ tắt cảnh báo.

Bước 5. Tăng $EtCO_2$ hoặc thay đổi dạng sóng: đánh giá thông khí, tắc nghẽn, thiết bị và nguyên nhân chuyển hóa; báo bác sĩ điều chỉnh. Không kết luận một nguyên nhân từ con số đơn lẻ.

Bước 6. Trong CPR dùng cùng chất lượng ép tim và các dấu hiệu khác; không dùng $EtCO_2$ đơn độc để quyết định ngừng hồi sức.

Bước 7. Ngừng theo chỉ định, tháo và xử lý phụ kiện; ghi giá trị xu hướng, dạng sóng, biến cố và can thiệp.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Bất thường $EtCO_2$ kèm giảm SpO_2 hoặc ý thức: xử trí đường thở hô hấp tuần hoàn ngay.

Ống đã đặt nhưng không xác nhận được vị trí: áp dụng quy trình kiểm tra đường thở, không mặc định máy lỗi.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

14 Theo dõi và sử dụng thuốc giảm đau liên tục

Mã đề xuất QT PTGMHS 14 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Đau là một triệu chứng phổ biến và thường gặp nhất ở người bệnh trong giai đoạn chu phẫu (trước, trong và sau phẫu thuật) và trong đơn vị hồi sức tích cực (ICU). Việc kiểm soát đau hiệu quả không chỉ mang lại sự thoải mái cho người bệnh mà còn giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, suy hô hấp, và giảm nguy cơ chuyển đau cấp tính thành đau mạn tính.

Quản lý đau trong GMHS là một quy trình đa phương thức (multimodal analgesia), kết hợp nhiều loại thuốc và kỹ thuật khác nhau (thuốc uống, tiêm tĩnh mạch, ngoài màng cứng, tê vùng) nhằm đạt hiệu quả tối ưu với tác dụng phụ tối thiểu. Phương pháp sử dụng thuốc giảm đau liên tục (thường qua đường truyền tĩnh mạch hoặc ngoài màng cứng) cho phép duy trì nồng độ thuốc ổn định trong máu hoặc tại vị trí tác dụng, đảm bảo hiệu quả giảm đau kéo dài.

2 Chỉ định

Đau cần giảm đau liên tục theo kế hoạch bác sĩ; chỉ áp dụng phương pháp được phê duyệt.

3 Chống chỉ định

Dị ứng thuốc được chọn; điều kiện không bảo đảm theo dõi và cấp cứu. Ngoài màng cứng có chống chỉ định riêng theo đông máu, nhiễm khuẩn, tuần hoàn và sự chấp thuận.

4 Thận trọng

Opioid gây an thần và suy hô hấp; người cao tuổi, suy gan thận, ngưng thở khi ngủ hoặc dùng thuốc an thần cần điều chỉnh. Không coi mọi bệnh gan thận là chống chỉ định tuyệt đối.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ GMHS kê kế hoạch; điều dưỡng được huấn luyện bơm và theo dõi, kiểm tra độc lập thuốc nguy cơ cao.

5.2 Thuốc

Y lệnh rõ tên, đường, nồng độ, liều mg hoặc microgam, tốc độ, liều bolus và khóa nếu PCA, giới hạn và tiêu chí dừng; thuốc cấp cứu và naloxone theo phác đồ.

5.3 Vật tư

Bơm tiêm hoặc túi thuốc, dây riêng được ghi nhãn đường dùng, nhãn thuốc và phiếu kiểm tra.

5.4 Trang thiết bị

Bơm tiêm điện hoặc bơm PCA tương thích, monitor, oxy, hút và phương tiện thông khí.

5.5 Người bệnh

Đánh giá đau, tỉnh táo, nhịp thở, SpO_2, huyết động và khả năng tự sử dụng PCA.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Liên tục theo chỉ định; kiểm tra sau khởi trị, đổi liều, bolus và mỗi bàn giao.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu chăm sóc đáp ứng mức giám sát và hồi sức.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra y lệnh và nguy cơ; chọn thang NRS VAS hoặc thang hành vi phù hợp và ghi mức đau trước điều trị.

Bước 2. Kiểm tra độc lập người bệnh, thuốc, nồng độ, đơn vị, phép tính và cài đặt bơm; đối chiếu đường tĩnh mạch hoặc ngoài màng cứng. Không hoán đổi đường dùng.

Bước 3. Gắn dây đúng đường, dán nhãn và xác nhận catheter; giữ kỹ thuật vô khuẩn, không bơm rửa đường ngoài màng cứng như đường tĩnh mạch.

Bước 4. Khởi truyền theo y lệnh, theo dõi trực tiếp đáp ứng. PCA chỉ người bệnh phù hợp tự bấm; người nhà không bấm thay. Truyền nền opioid phải có chỉ định riêng.

Bước 5. Đánh giá đau, an thần, nhịp thở, SpO_2 và huyết động theo mức nguy cơ, tăng sau liều bổ sung. Nếu giảm tỉnh hoặc thở bất thường ngừng hoặc tạm dừng theo tiêu chí và gọi bác sĩ.

Bước 6. Ngoài màng cứng hoặc tê vùng: đánh giá mức phong bế, vận động, cảm giác, huyết động và catheter. Thuốc chống đông và thời điểm rút catheter phải được bác sĩ xác nhận.

Bước 7. Bàn giao liều đã dùng, lượng còn lại, cài đặt, đánh giá đau và bất thường; kết thúc theo chỉ định và xử lý thuốc dư theo quy định.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Suy hô hấp do opioid: ngừng cấp thuốc, gọi cấp cứu, bảo đảm đường thở và hỗ trợ thông khí; naloxone theo y lệnh hoặc phác đồ được duyệt, theo dõi tái suy hô hấp.

Tụt huyết áp: đánh giá chảy máu, giảm thể tích và mức tê; bác sĩ điều chỉnh điều trị.

Buồn nôn, bí tiểu, ngứa: đánh giá nguyên nhân và thực hiện y lệnh, không đặt thông tiểu hoặc thêm thuốc thường quy cho mọi trường hợp.

Đau lưng mới, yếu chân tăng, rối loạn cảm giác hoặc cơ tròn sau ngoài màng cứng: báo bác sĩ và hội chẩn khẩn nghi tụ máu chèn ép. Không tự rút catheter như một xử trí đủ.

Nghi LAST khi truyền thuốc tê: ngừng truyền và theo phụ lục LAST.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

2. ASRA Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity, 2020. Nguồn đối chiếu

3. Chou R và cộng sự Management of Postoperative Pain, J Pain 2016;17:131–157. Nguồn đối chiếu

15 Thay băng vết mổ

Mã đề xuất QT PTGMHS 15 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Đánh giá và bảo vệ vết mổ bằng kỹ thuật vô khuẩn phù hợp; NaCl 0,9% vô khuẩn là dung dịch làm sạch, không phải thuốc sát khuẩn.

2 Chỉ định

Người bệnh sau phẫu thuật có vết mổ.

Vết mổ có băng cũ bị ướt, bẩn, bong hoặc thấm dịch.

Vết mổ có dẫn lưu (theo chỉ định bác sĩ).

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định chung; chảy máu đang tiến triển hoặc bục vết mổ cần bác sĩ đánh giá và xử trí ngay.

4 Thận trọng

Không làm sạch xâm lấn hoặc cắt lọc ngoài chỉ định; không sát khuẩn mạnh vào nền mô lành thường quy.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng có năng lực thay băng; bác sĩ chỉ định xử trí vết phức tạp.

5.2 Thuốc

NaCl 0,9% vô khuẩn; sản phẩm khác dùng theo tình trạng, chỉ định và hướng dẫn tương thích.

5.3 Vật tư

Bộ vô khuẩn, gạc, băng phù hợp, găng sạch và vô khuẩn hoặc kỹ thuật không chạm, tấm lót, túi chất thải.

5.4 Trang thiết bị

Giường và ánh sáng, dụng cụ đánh giá vết thương.

5.5 Người bệnh

Giải thích, đánh giá đau và chuẩn bị tư thế kín đáo.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo mức độ vết mổ; thay khi băng bẩn, ướt, bong hoặc theo chỉ định, không bắt buộc một lịch chung.

5.8 Địa điểm thực hiện

Buồng bệnh hoặc phòng thủ thuật phù hợp.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra người bệnh, vết mổ, y lệnh, dị ứng, đau; chuẩn bị vật tư và vệ sinh tay.

Bước 2. Bộc lộ vừa đủ, đặt tấm lót; dùng găng sạch tháo băng cũ nhẹ nhàng, quan sát dịch và bỏ đúng chất thải.

Bước 3. Tháo găng, vệ sinh tay; mở bộ vô khuẩn và thiết lập vùng sạch, không dùng kẹp đã chạm băng bẩn cho phần sạch.

Bước 4. Đánh giá mép mổ, da, dịch, đau, đỏ nóng và dấu chảy máu; nếu cần lấy mẫu thực hiện đúng chỉ định trước khi xử lý làm ảnh hưởng kết quả.

Bước 5. Khi cần làm sạch, dùng NaCl 0,9% vô khuẩn và kỹ thuật không chạm; từ vùng sạch đến vùng ít sạch hơn, mỗi gạc một lượt. Không chà mạnh hoặc mặc định rửa mọi vết kín khô.

Bước 6. Dùng sát khuẩn hoặc băng đặc hiệu chỉ khi phù hợp và được chỉ định; theo hướng dẫn sản phẩm. Không bắt buộc bôi povidone iodine và lau 2–3 lượt cho mọi vết mổ.

Bước 7. Đặt băng phù hợp, cố định không chèn ép, xử lý vị trí dẫn lưu theo quy trình riêng và đánh giá đau sau thao tác.

Bước 8. Thu dọn, vệ sinh tay, hướng dẫn giữ băng; ghi thời điểm, vết mổ, sản phẩm, đáp ứng và người thực hiện.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Chảy máu, bục mép hoặc lộ tạng: dừng thao tác không cần thiết, bảo vệ vết và gọi bác sĩ khẩn theo tình trạng.

Đau tăng, sưng đỏ, dịch mủ, sốt: báo bác sĩ đánh giá nhiễm khuẩn; không chỉ thay băng lại.

Tài liệu đối chiếu

1. NICE NG125 Surgical site infections prevention and treatment. Nguồn đối chiếu

16 Gây mê tĩnh mạch với hỗ trợ thông khí qua mặt nạ

Mã đề xuất QT PTGMHS 16 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Gây mê toàn thân bằng thuốc tĩnh mạch với đường thở và hỗ trợ thông khí được bác sĩ lựa chọn. Mặt nạ không bảo vệ chắc chắn khỏi hít sặc; không mặc định mọi nội soi đều dùng cùng phác đồ.

2 Chỉ định

Phẫu thuật thời gian ngắn < 60 phút.

Phẫu thuật không đòi hỏi giãn cơ.

Phẫu thuật ngoài ổ bụng, ngực.

Phẫu thuật ngoại trú.

Người bệnh có tình trạng hô hấp, tuần hoàn ổn định.

Người bệnh được nhịn ăn uống đủ thời gian.

3 Chống chỉ định

Không dùng thuốc dị ứng hoặc phương pháp không đáp ứng kiểm soát đường thở, thông khí và nguy cơ hít sặc. Không thực hiện khi thiếu nhân lực chuyên môn hoặc phương tiện hồi sức.

4 Thận trọng

Bệnh tim phổi, người cao tuổi, béo phì, ngưng thở khi ngủ, cấp cứu chưa nhịn đủ; bác sĩ quyết định phương pháp khác khi nguy cơ vượt khả năng mặt nạ.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ GMHS chịu trách nhiệm và nhân viên gây mê hỗ trợ; có người chuyên trách theo dõi, không kiêm thao tác làm mất giám sát.

5.2 Thuốc

Thuốc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch cá thể hóa; ghi rõ tên, nồng độ, liều, đường và tốc độ. Không dùng liều bolus ghi bằng mL thiếu nồng độ hoặc thêm atropine benzodiazepine thường quy cho mọi ca.

5.3 Vật tư

Bơm tiêm ghi nhãn, vật tư đường truyền, mặt nạ phù hợp và đường thở dự phòng.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động. Máy gây mê hoặc hệ thống thông khí, capnography, theo dõi nhiệt độ khi cần.

5.5 Người bệnh

Khám GMHS và chấp thuận, kiểm tra nhịn ăn nguy cơ hít sặc, tháo vật ảnh hưởng đường thở và đường truyền chắc chắn.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Trong can thiệp và hồi tỉnh theo kế hoạch.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng mổ hoặc khu thủ thuật đủ điều kiện vô cảm và hồi sức.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra bảng an toàn, máy, đường thở dự phòng, thuốc và liều, oxy hút và monitor; bác sĩ xác nhận kế hoạch vô cảm.

Bước 2. Gắn theo dõi điện tim SpO_2 và huyết áp, đánh giá thông khí; trong vô cảm đo mạch huyết áp ít nhất mỗi 5 phút theo chuẩn ASA khi áp dụng và thường xuyên hơn nếu bất ổn.

Bước 3. Đặt tư thế đường thở phù hợp, tiền oxy hóa theo đánh giá bác sĩ; không coi oxy mũi 3–5 L/phút là tương đương hít oxy 100%.

Bước 4. Bác sĩ khởi mê, chỉnh liều theo đáp ứng và đặc điểm thuốc; hỗ trợ mặt nạ, quan sát hô hấp và capnography. Không chỉ dựa SpO_2 để phát hiện giảm thông khí.

Bước 5. Duy trì vô cảm và thông khí, kiểm tra đường truyền, huyết động và thân nhiệt; chuyển dụng cụ trên thanh môn hoặc đặt nội khí quản khi mặt nạ không đáp ứng theo kế hoạch đường thở.

Bước 6. Giảm và ngừng thuốc phù hợp, đánh giá hồi phục hô hấp ý thức, biến chứng và bàn giao hồi tỉnh với giám sát liên tục.

Bước 7. Ghi thuốc tổng liều, thời điểm, hỗ trợ đường thở, sinh hiệu, biến cố và đáp ứng.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Giảm thông khí hoặc ngừng thở: ngừng thuốc hoặc chỉnh theo bác sĩ, gọi hỗ trợ, mở đường thở, oxy hóa và thông khí; xử trí co thắt hoặc hít sặc theo phác đồ.

Thoát mạch: ngừng truyền tại vị trí, đánh giá thuốc và tổn thương, hút lại nếu phù hợp hướng dẫn thuốc; không tự bơm rửa hoặc tiêm lidocaine tại mô thường quy.

Nghi tiêm nhầm động mạch: ngừng ngay, đánh giá tưới máu và hội chẩn GMHS mạch máu; không tiêm thêm lidocaine hoặc papaverine theo công thức chung của nguồn.

Tụt huyết áp, phản vệ hoặc rối loạn nhịp: xử trí theo nguyên nhân và phác đồ cấp cứu; kháng histamine không đủ điều trị phản vệ.

Hồi tỉnh theo dõi đường thở, đau, nôn và vận động; xuất viện theo tiêu chí được duyệt và người hỗ trợ, không tự lái xe sau vô cảm.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

17 Đặt nội khí quản

Mã đề xuất QT PTGMHS 17 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Đưa ống vào khí quản để thông khí hoặc bảo vệ đường thở khi có chỉ định. Quy trình này mô tả đặt qua miệng; đường mũi và đường thở khó có kế hoạch riêng.

2 Chỉ định

Kiểm soát đường thở

Không duy trì hoặc bảo vệ đường thở.

Ngưng tuần hoàn hô hấp

Thất bại trong thông khí do tắc nghẽn hay thông khí không đầy đủ.

Diễn tiến lâm sàng xấu dần trong tình huống đánh giá suy hô hấp nặng trước đó chuyển sang nguy kịch.

3 Chống chỉ định

Không có chống chỉ định tuyệt đối cho bảo đảm đường thở cứu sống. Chấn thương cổ, tắc nghẽn hoặc tổn thương đường thở đòi hỏi lựa chọn phương pháp chuyên biệt, không tự coi là lý do bỏ kiểm soát đường thở.

4 Thận trọng

Nguy cơ không đặt được hoặc không thông khí được, hít sặc, tụt huyết áp, thiếu oxy; ưu tiên oxy hóa và giới hạn số lần thử theo kế hoạch đường thở khó.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ hoặc người được phân công hợp pháp có năng lực kiểm soát đường thở; điều dưỡng hỗ trợ chuẩn bị, thuốc theo y lệnh, theo dõi và cố định.

5.2 Thuốc

Thuốc khởi mê, giảm đau, giãn cơ hoặc gây tê do bác sĩ chọn theo tình trạng; chuẩn bị thuốc hồi sức phù hợp, không áp dụng thuốc thường quy khi không cần.

5.3 Vật tư

Ống đúng cỡ với cỡ dự phòng, bơm, vật tư cố định, nòng phù hợp, găng và PPE.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động. Đèn soi hoặc video, capnography dạng sóng, dụng cụ đo áp lực cuff và đường thở cứu hộ.

5.5 Người bệnh

Đánh giá đường thở, tư thế, nhịn ăn và nguy cơ sặc, cổ, huyết động; tiền oxy hóa phù hợp, không kê gối cố định khi chấn thương cổ.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo tình trạng; không kéo dài lần đặt gây thiếu oxy.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu đủ điều kiện hồi sức; cấp cứu tại chỗ an toàn khi cần.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Gọi hỗ trợ phù hợp, kiểm tra danh tính chỉ định và phương án A B C cứu hộ; phân công, kiểm tra oxy, hút, capnography, ống và thuốc.

Bước 2. Gắn theo dõi, tối ưu tư thế và huyết động, tiền oxy hóa theo điều kiện; thuốc do bác sĩ chỉ định và thực hiện trong kế hoạch kiểm soát đường thở.

Bước 3. Mở miệng và đưa lưỡi soi đúng kỹ thuật; với lưỡi cong đặt vào hõm nắp thanh môn, nâng theo trục cán, không bẩy vào răng.

Bước 4. Nhìn thanh môn và đưa ống qua dây thanh dưới quan sát; đưa cuff qua thanh môn đủ mức, không áp độ sâu cố định cho mọi lứa tuổi.

Bước 5. Rút nòng đúng cách, nối hệ thống và bơm cuff theo áp lực mục tiêu của loại ống; ở người lớn thường đối chiếu 20–30 cmH_2O, không bơm 6–10 mL cố định.

Bước 6. Xác nhận vị trí bằng CO_2 thở ra dạng sóng duy trì cùng khám lâm sàng, lồng ngực và nghe phổi; SpO_2 và nghe phổi đơn độc không đủ. Nếu chưa chắc vị trí phải đánh giá ngay, không tiếp tục thông khí qua ống nghi nằm thực quản.

Bước 7. Cố định, ghi cỡ và độ sâu tại răng hoặc môi, áp lực cuff, xác nhận capnography; kiểm tra lại sau đổi tư thế hoặc vận chuyển.

Bước 8. Đánh giá thông khí, huyết động, an thần giảm đau theo y lệnh; kiểm tra vị trí bằng phương tiện bổ sung khi chỉ định và bàn giao.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Đặt nhầm thực quản: rút ống, oxy hóa thông khí và đánh giá lại phương án. Tụt SpO_2 hoặc khó thông khí: ưu tiên hồi sức oxy hóa, gọi hỗ trợ và thực hiện thuật toán đường thở khó.

Ống quá sâu, tắc hoặc tụt: đánh giá, chỉnh hoặc thay bởi người có năng lực và xác nhận lại.

Chấn thương, tụt huyết áp hoặc phản ứng thuốc: xử trí nguyên nhân và ghi sự cố. Trong ngừng tuần hoàn không trì hoãn ép tim và thông khí hiệu quả để đặt ống.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

2. Hướng dẫn nhà sản xuất ống và thiết bị, thuật toán đường thở khó được bệnh viện phê duyệt.

18 Rút nội khí quản

Mã đề xuất QT PTGMHS 18 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Rút ống khi hết chỉ định và đạt tiêu chí bảo vệ đường thở, thông khí và huyết động theo bác sĩ. Phân biệt rút sau gây mê với cai máy ở hồi sức.

2 Chỉ định

Hết chỉ định đặt ống, đáp ứng tiêu chí rút và có kế hoạch theo dõi cùng tái đặt.

3 Chống chỉ định

Chưa bảo vệ được đường thở, thông khí không đủ, huyết động chưa phù hợp hoặc nguy cơ tắc nghẽn chưa được giải quyết: chưa rút theo kế hoạch thường quy.

4 Thận trọng

Đường thở khó, béo phì, ngưng thở khi ngủ, phù nề, tồn dư thuốc mê và giãn cơ; cần phương án tái đặt. Không dùng nâng đầu 5 giây thay xác nhận hồi phục giãn cơ.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ GMHS hoặc hồi sức quyết định và thực hiện; điều dưỡng hỗ trợ giám sát.

5.2 Thuốc

Thuốc phục hồi giãn cơ, oxy và thuốc cấp cứu theo y lệnh, không dùng corticoid thường quy chỉ vì rút ống.

5.3 Vật tư

Vật tư hút, oxy, mặt nạ, cố định và vật tư đặt lại.

5.4 Trang thiết bị

Nguồn oxy, bóng và mặt nạ phù hợp, máy hút, dụng cụ kiểm soát đường thở khó, máy sốc điện, monitor và xe cấp cứu đã kiểm tra hoạt động. Theo dõi thần kinh cơ định lượng khi có dùng thuốc giãn cơ.

5.5 Người bệnh

Đánh giá ý thức, ho bảo vệ, tiết dịch, thông khí, huyết động và nguy cơ phù nề; giải thích nếu tỉnh.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Đến khi ổn định sau rút, tăng giám sát theo nguy cơ.

5.8 Địa điểm thực hiện

Hồi tỉnh, phòng mổ hoặc hồi sức đáp ứng đặt lại.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Bác sĩ xác nhận tiêu chí rút, kế hoạch oxy hỗ trợ và tái đặt; với cai máy ở hồi sức đánh giá nghiệm pháp tự thở khi có chỉ định.

Bước 2. Xác nhận tự thở hiệu quả, oxy hóa trong mức hỗ trợ phù hợp, khả năng ho và bảo vệ đường thở. Khi dùng thuốc giãn cơ, dùng theo dõi định lượng xác nhận TOF ≥0,9 trước rút theo hướng dẫn ASA; không dựa riêng dấu cơ lực.

Bước 3. Chuẩn bị và kiểm tra phương tiện đặt lại, bố trí tư thế phù hợp; tối ưu oxy hóa theo bác sĩ, không áp một nhịp thở hoặc SpO_2 cố định làm tiêu chí duy nhất.

Bước 4. Hút dịch miệng họng và trong ống khi cần theo kỹ thuật, tránh kích thích và thiếu oxy; kiểm tra cuff và các vật cần tháo.

Bước 5. Khi ê-kíp sẵn sàng, xả hoàn toàn cuff và rút ống theo kế hoạch bác sĩ; đánh giá ngay đường thở, thở, ho, SpO_2 và huyết động.

Bước 6. Cho oxy hoặc hỗ trợ hô hấp theo mục tiêu; theo dõi trực tiếp giai đoạn đầu và theo lịch đã duyệt, tăng giám sát ở người nguy cơ cao.

Bước 7. Ghi thời điểm, tiêu chí, hỗ trợ sau rút, sinh hiệu và biến cố; bàn giao kế hoạch và ngưỡng gọi bác sĩ.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Thở rít, tắc nghẽn, giảm thông khí hoặc SpO_2: gọi hỗ trợ ngay, mở đường thở và hỗ trợ oxy hóa thông khí; bác sĩ xử trí co thắt, phù nề và quyết định đặt lại. Không trì hoãn đặt lại khi thất bại.

Theo dõi nguy cơ hít sặc và suy hô hấp tái diễn; điều chỉnh mức chăm sóc sau rút.

Tài liệu đối chiếu

1. ASA Practice Guidelines for Monitoring and Antagonism of Neuromuscular Blockade, 2023. Nguồn đối chiếu

2. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

19 Làm sạch và khử khuẩn máy thở cùng phụ kiện

Mã đề xuất QT PTGMHS 19 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Xử lý bề mặt và các bộ phận theo nguy cơ, tính tái sử dụng và hướng dẫn nhà sản xuất; làm sạch phải trước khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn.

2 Chỉ định

Khi bẩn, theo lịch bề mặt và sau người bệnh, hoặc theo hướng dẫn phụ kiện.

3 Chống chỉ định

Không tháo, tắt máy đang hỗ trợ người bệnh để vệ sinh thường quy. Không tái xử lý vật tư dùng một lần hoặc dùng hóa chất, chu trình không tương thích.

4 Thận trọng

Bảo đảm thông khí thay thế trước bất kỳ ngắt kết nối cần thiết; tránh nước vào điện, cảm biến, nguy cơ hóa chất và nhiễm khuẩn.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên được đào tạo; phối hợp KSNK, đơn vị tiệt khuẩn và thiết bị y tế.

5.2 Thuốc

Không có thuốc; hóa chất làm sạch và khử khuẩn đúng sản phẩm, nồng độ, thời gian tiếp xúc và tương thích vật liệu.

5.3 Vật tư

Khăn, PPE, dụng cụ riêng, hộp vận chuyển kín; phụ kiện thay thế đủ.

5.4 Trang thiết bị

Thiết bị máy thở đúng model, khu xử lý sạch bẩn và công cụ kiểm tra chức năng.

5.5 Người bệnh

Nếu đang thở máy, bảo đảm không ảnh hưởng hỗ trợ; vệ sinh sâu sau chuyển người bệnh hoặc có máy thay thế.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo lịch, sự nhiễm bẩn và chu trình sản phẩm; không tự rút ngắn thời gian hóa chất.

5.8 Địa điểm thực hiện

Bề mặt tại buồng bệnh khi an toàn, bộ phận tháo rời chuyển khu xử lý theo phân luồng.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Xác nhận máy còn đang dùng hay đã ngừng hỗ trợ, lập phương án an toàn; đọc hướng dẫn model và phân loại từng bộ phận tái sử dụng hoặc dùng một lần.

Bước 2. Mang PPE, vệ sinh tay. Máy không đang hỗ trợ: tắt và ngắt điện theo hướng dẫn trước xử lý; máy đang dùng chỉ lau ngoài theo hướng dẫn mà không ngắt hỗ trợ.

Bước 3. Lau làm sạch bề mặt rồi khử khuẩn bằng sản phẩm tương thích, giữ đủ thời gian tiếp xúc; không phun trực tiếp hoặc tự chọn cồn chlorine cho mọi bề mặt.

Bước 4. Dây thở và phụ kiện tái sử dụng tiếp xúc đường hô hấp: tháo, vận chuyển kín, làm sạch, tráng và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn. Phụ kiện dùng một lần phải thải bỏ, không ngâm để dùng lại.

Bước 5. Van, cảm biến và bộ lọc xử lý theo từng loại; không mặc định tất cả đều được ngâm hóa chất. HME HEPA dùng một lần thay khi chỉ định hoặc theo sản phẩm, không giặt hoặc khử khuẩn lại.

Bước 6. Tráng, làm khô và bảo quản bộ phận sau xử lý theo mức yêu cầu sản phẩm và KSNK. Không gọi mọi bề mặt đã khử khuẩn là vô khuẩn.

Bước 7. Lắp đúng hướng, kiểm tra rò, tự kiểm tra và hiệu chuẩn theo thiết bị, cài báo động; không đưa máy lỗi vào dùng.

Bước 8. Ghi máy, bộ phận, hóa chất, nồng độ, thời gian tiếp xúc, chu trình và người thực hiện; xử lý chất thải và vệ sinh tay.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Ngắt kết nối hoặc thay đổi thông khí khi đang chăm sóc: hỗ trợ người bệnh ngay, kiểm tra hệ thống, báo bác sĩ.

Hóa chất không tương thích, dư hóa chất, hỏng cảm biến hoặc tự kiểm tra thất bại: cách ly bộ phận hoặc máy, báo thiết bị và KSNK. Dây thở không thay định kỳ chỉ để giảm nhiễm khuẩn nếu còn sạch và hoạt động, nhưng phải theo hướng dẫn sản phẩm.

Tài liệu đối chiếu

1. CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Summary Recommendations. Nguồn đối chiếu

2. Hướng dẫn sử dụng, làm sạch và tái xử lý của đúng model máy thở cùng từng phụ kiện.

Phụ lục cấp cứu nghi ngộ độc thuốc tê toàn thân

Nội dung đối chiếu chuyên môn để khoa GMHS xác nhận thành phác đồ tại chỗ. Dùng cùng bộ LAST và phiên bản phác đồ được duyệt, không thay xử trí phản vệ. LAST có thể xảy ra với nhiều thuốc tê.

Ngừng thuốc tê và gọi đội cấp cứu; bảo đảm đường thở, oxy hóa, thông khí, xử trí co giật ưu tiên benzodiazepine. Hồi sức LAST có khác biệt với ACLS thông thường; bác sĩ chỉ huy cần dùng bảng kiểm chuyên biệt.

Đối chiếu nhũ tương lipid 20% theo ASRA 2020: dưới 70 kg, bolus khoảng 1,5 mL/kg trong 2–3 phút rồi truyền khoảng 0,25 mL/kg/phút; trên 70 kg, bolus khoảng 100 mL trong 2–3 phút rồi khoảng 250 mL trong 15–20 phút. Mốc đúng 70 kg cần bác sĩ áp dụng nhánh phù hợp theo phác đồ tại bệnh viện.

Còn bất ổn: cân nhắc lặp bolus và tăng gấp đôi tốc độ truyền; tiếp tục hơn 15 phút sau ổn định huyết động, tổng tối đa 12 mL/kg. Kiểm tra nồng độ 20%, cân nặng và đơn vị trước dùng; không thay bằng propofol.

Trong hồi sức LAST, ASRA ưu tiên liều adrenaline nhỏ hơn thường quy, khởi đầu dưới 1 microgam/kg; tránh vasopressin, chẹn beta, chẹn kênh calcium và thêm thuốc tê. Đây là xử trí do bác sĩ điều hành theo phác đồ LAST, không phải thay đổi liều adrenaline của mọi ngừng tuần hoàn.

Sau ổn định theo dõi ít nhất 2 giờ sau co giật, 4–6 giờ sau bất ổn tim mạch; sau ngừng tuần hoàn tùy tình trạng. Ghi toàn bộ thuốc tê, tổng mg, biểu hiện, thời điểm và liều lipid.

Tài liệu đối chiếu

1. ASRA Checklist for Treatment of Local Anesthetic Systemic Toxicity, 2020. Nguồn đối chiếu

Biểu mẫu ghi nhận và bàn giao

Dùng cùng hồ sơ bệnh án; lựa chọn ô phù hợp kỹ thuật, không thay phiếu gây mê hoặc y lệnh. Người ghi xác nhận các việc đã thực hiện.

Họ tên người bệnh …… Mã hồ sơ …… Ngày giờ ……

Kỹ thuật và vị trí bên ……

Chỉ định bác sĩ …… Người thực hiện ……

Hai thông tin định danh đã kiểm tra ……

Dị ứng và thuốc liều cuối ……

Đánh giá trước can thiệp và nguy cơ ……

Thuốc tên nồng độ liều mg đường dùng thời điểm ……

Thiết bị và kiểm tra an toàn ……

Các bước và kết quả ……

Bất thường thời gian xử trí đáp ứng ……

Theo dõi sau can thiệp và tiêu chí bàn giao ……

Người giao …… Người nhận …… Giờ ……

Các nội dung cần xác nhận trước ban hành

Nội dung	Đơn vị xác nhận
Đề cương QĐ3023 và mã tài liệu	Phòng Điều dưỡng và quản lý văn bản
Thuốc tê tổng liều giới hạn pha phối hợp và sơ đồ gây tê	Khoa GMHS và khoa Dược
Thuốc mê giảm đau phác đồ LAST và phản vệ	Khoa GMHS khoa Dược và Hội đồng chuyên môn
Đường thở khó tiêu chí rút ống hồi tỉnh và chuyển khoa	Khoa GMHS và khoa Hồi sức
Thiết bị làm ấm máy thở phụ kiện hóa chất	Bộ phận thiết bị y tế KSNK và khoa sử dụng
Bản ký QĐ782 và phụ lục chuyên ngành liên quan	Khoa GMHS và bộ phận pháp chế

Kết quả thẩm định và nội dung điều chỉnh
……
Ngày phê duyệt …… Người phê duyệt
……